



ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS : ENTRE PROGRES THERAPEUTIQUE ET CONTRAINTES DE PRESCRIPTION EN ALGERIE



CHELLIL Maroua¹, BOUNAAS SARRA², BOUHEDADJA Zahia¹



Affiliation : ¹laboratoire de pharmacologie, département de pharmacie, faculté de médecine, université Ferhat Abbas -Sétif 1
² laboratoires d'hémodiagnostic et transfusion sanguine, CHU Saadna Abdenour - Sétif
Chellil.ma24@gmail.com

Introduction

Depuis 2008, des « nouveaux » anticoagulants oraux directs (AOD) font leur apparition sur le marché, avec plusieurs avantages, notamment un effet anticoagulant plus prédictible, une stabilité plus importante des taux plasmatiques et, par conséquent, l'éventuelle absence de nécessité de suivre l'activité anticoagulante. En outre, ils permettent une anticoagulation aussi efficace, avec moins d'hémorragies intracrâniennes que les AVK.

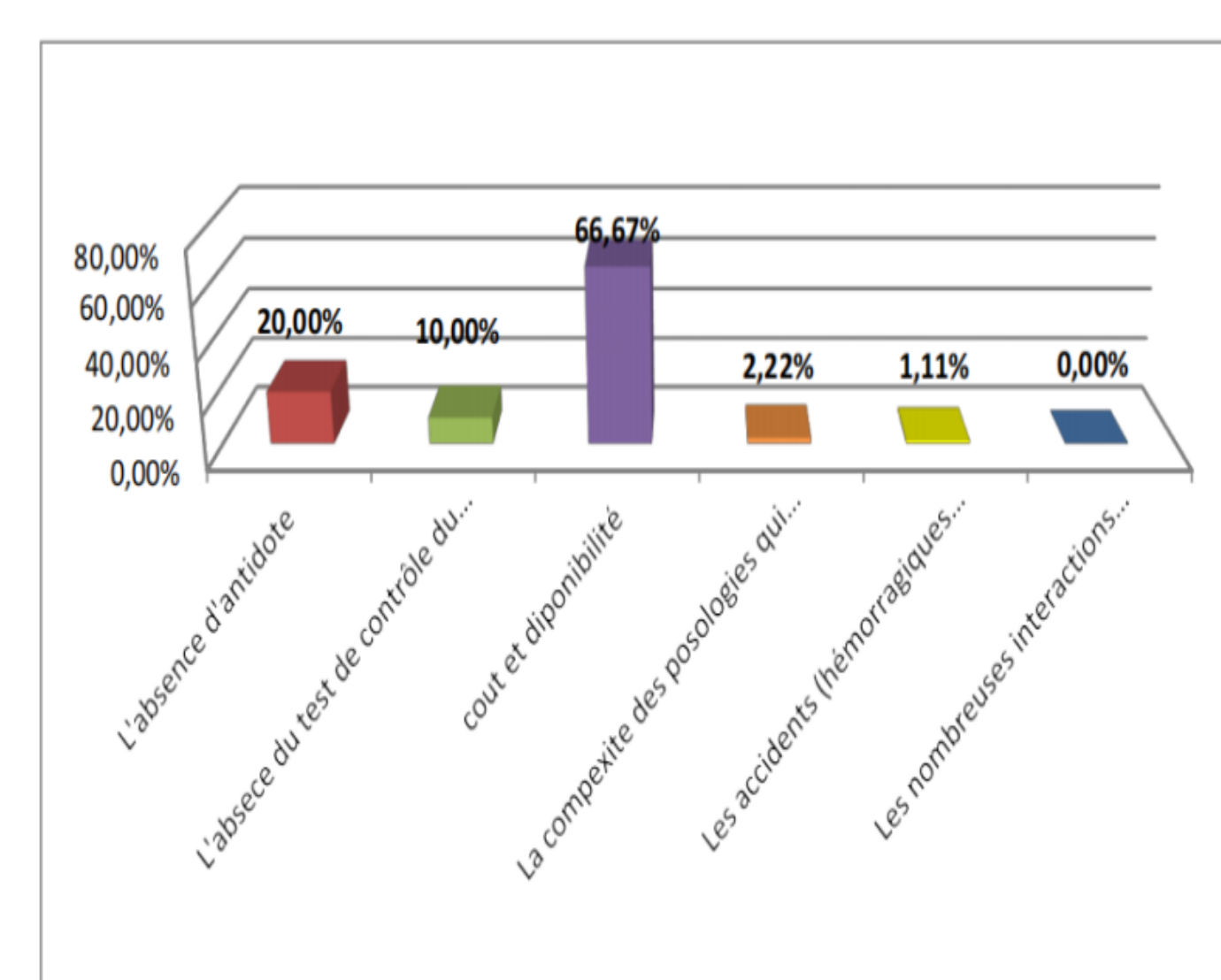
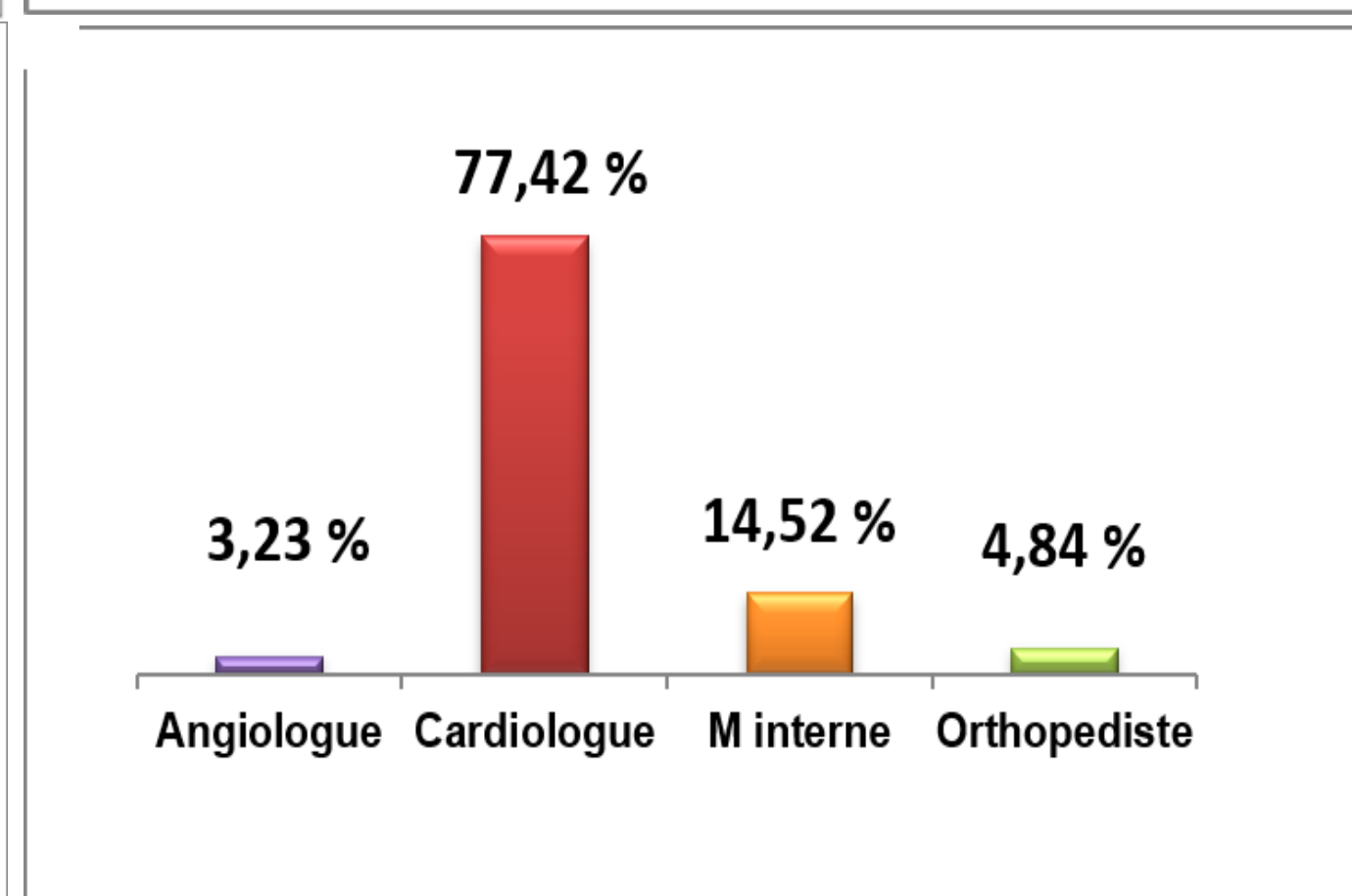
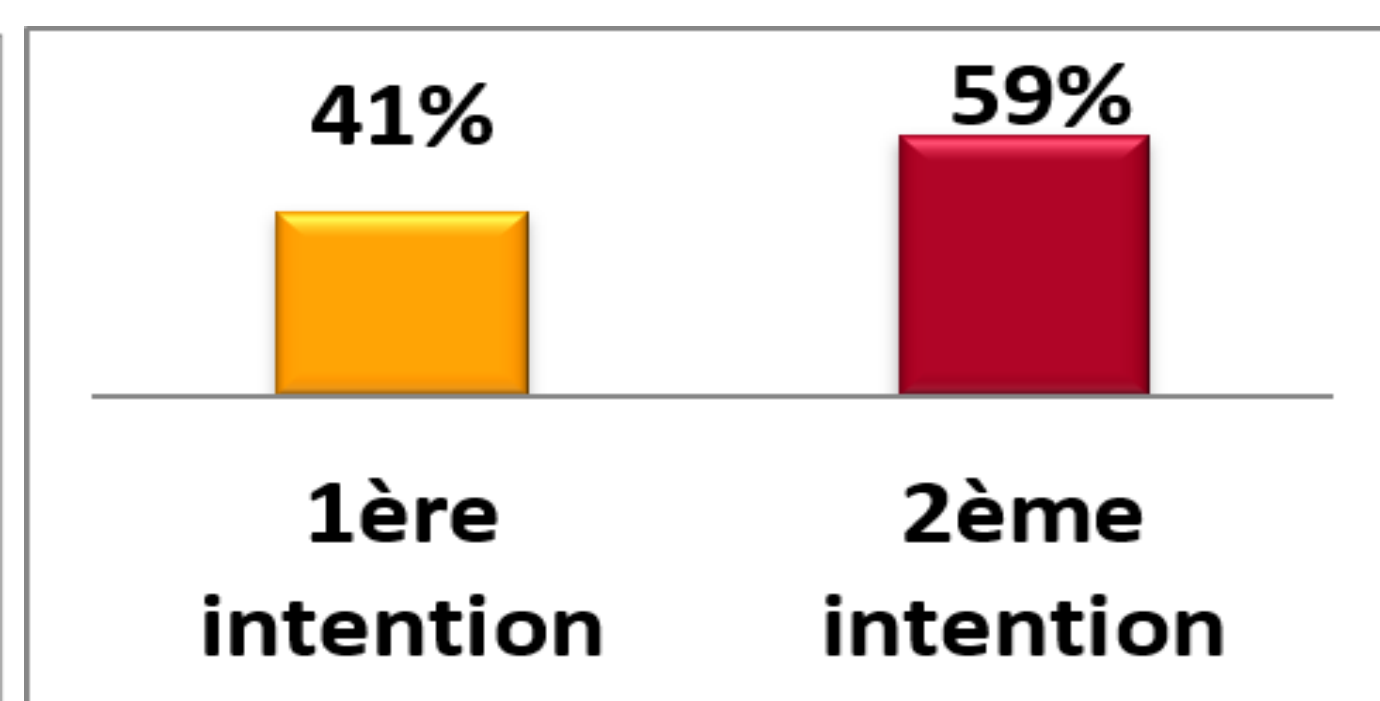
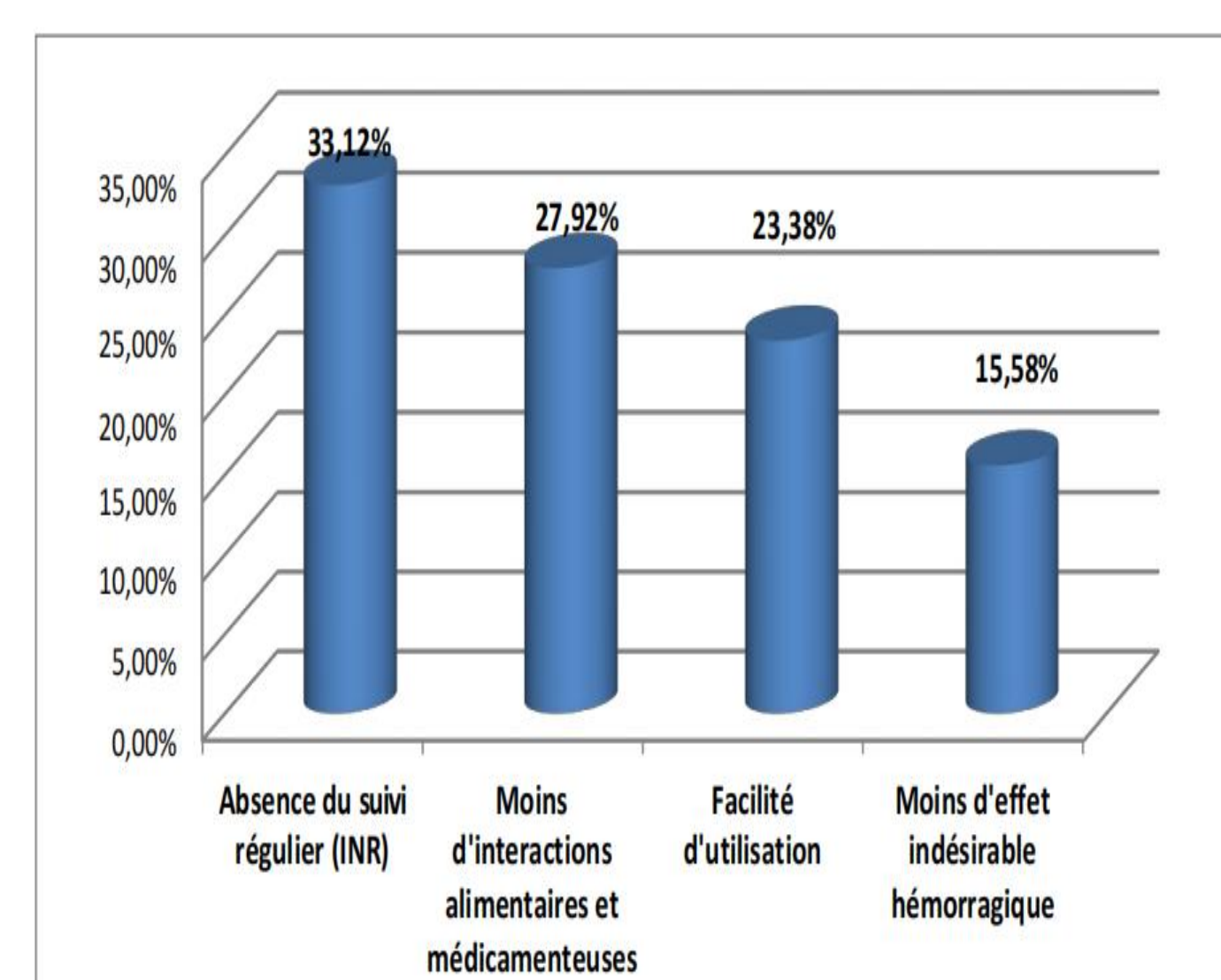
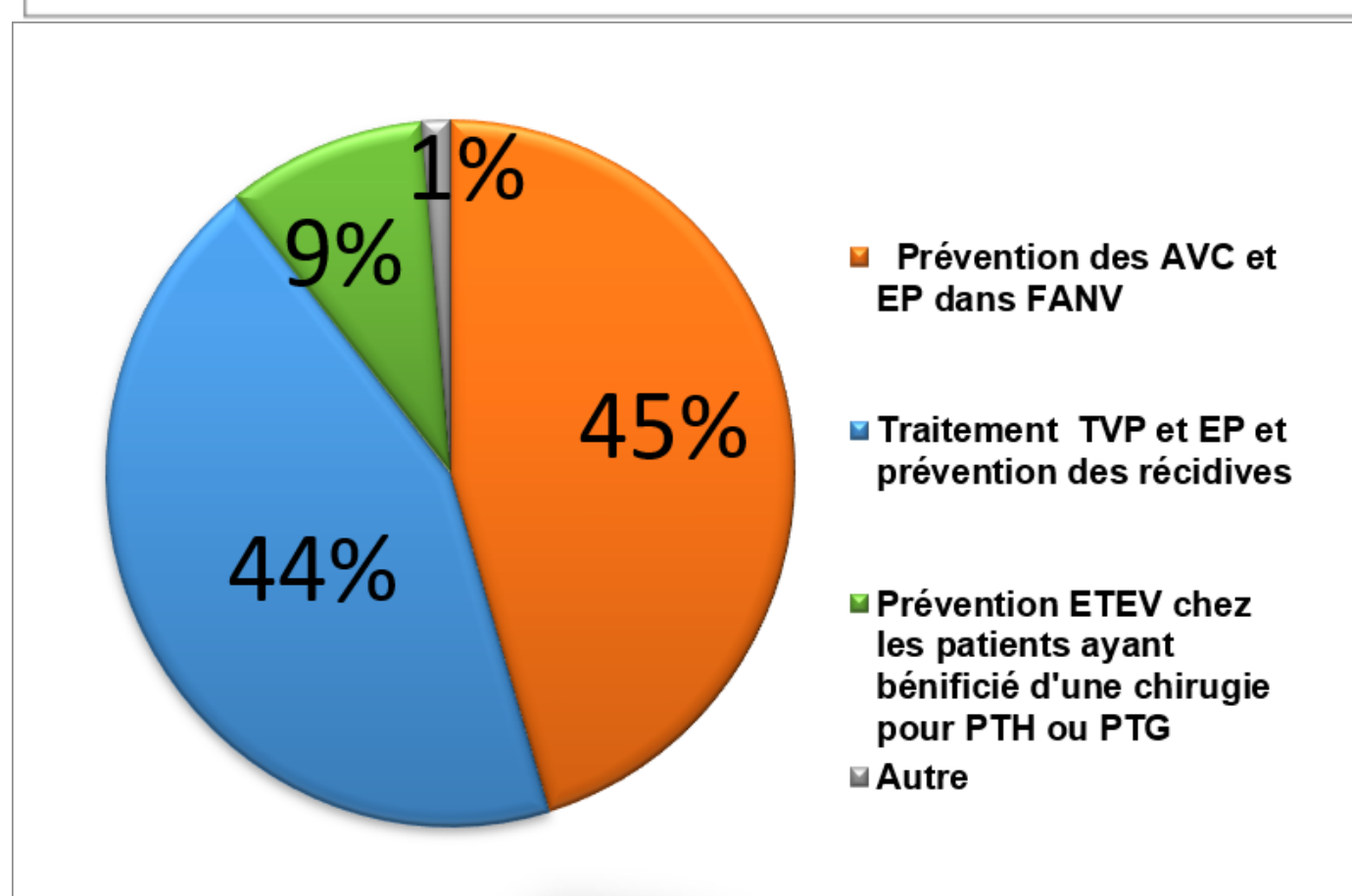
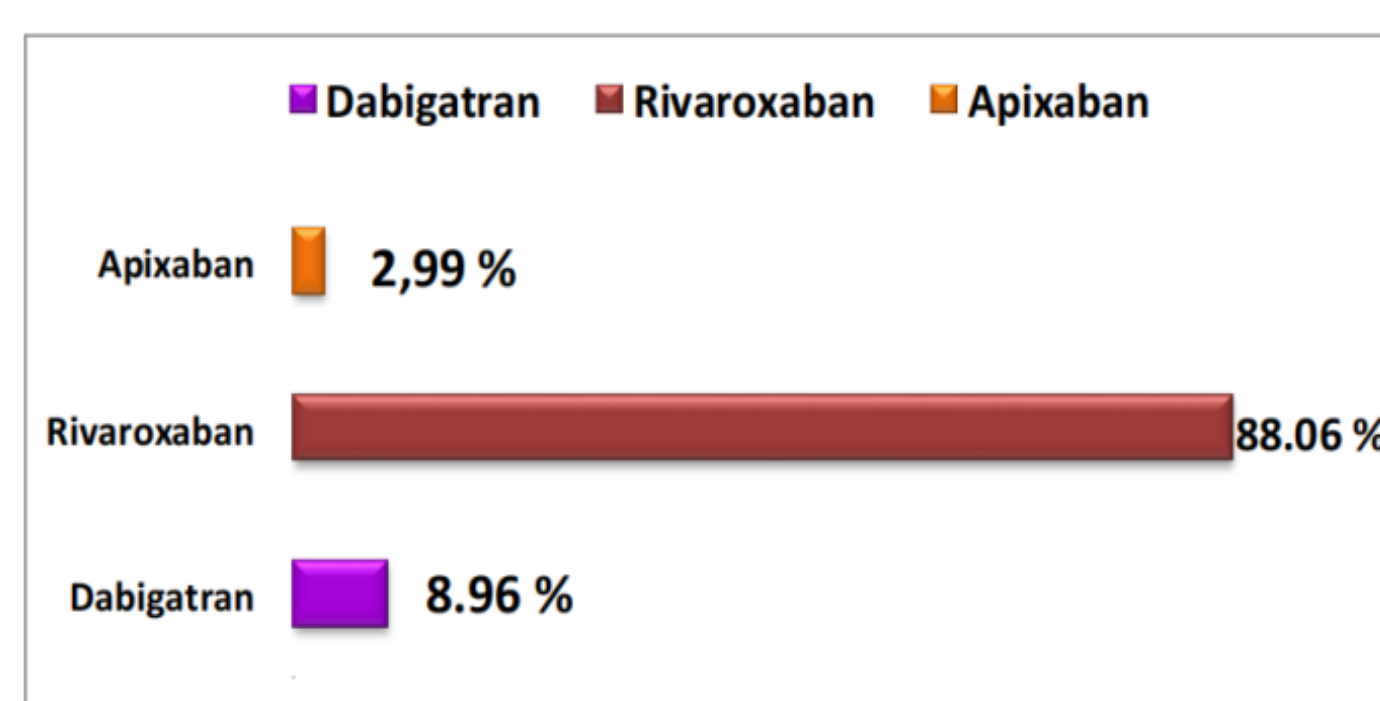
Matériels et méthodes

Nous avons procédé à une étude transversale déclarative menée auprès des médecins **spécialistes** hospitaliers et libéraux (cardiologues, internistes et orthopédistes) dans les wilayas de : Sétif, M'ssila, Bordj Bou Arreridj, Alger et Boumerdes) à l'aide d'un questionnaire.

Pour optimiser la participation, le questionnaire est rempli anonymement et rédigé sous deux formes de contenu identique : Une version papier et Une version électronique afin de permettre une meilleure participation.

La version papier a été rédigée à l'aide du logiciel Microsoft Word 2007, la version électronique a été rédigée via Google Drive. Le recueil et l'analyse des résultats a été fait par Excel. Cette étude avait pour objectif d'évaluer leur utilisation et d'identifier les obstacles à leur prescription.

Résultats



Discussion

Cette étude montre que l'initiation du traitement par les anticoagulants oraux directs (AOD) est principalement assurée par les cardiologues. Cette prédominance pourrait s'expliquer par l'orientation rapide des patients présentant une suspicion de fibrillation atriale non valvulaire, de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire vers les spécialistes en cardiologie.

Le rivaroxaban constitue de loin l'AOD le plus prescrit, représentant 88 % des prescriptions. L'apixaban et le dabigatran sont, quant à eux, beaucoup moins utilisés. Cette répartition semble principalement liée à la disponibilité limitée de ces molécules sur le marché algérien, le rivaroxaban étant largement accessible. Par ailleurs, 41 % des médecins déclarent prescrire les AOD en première intention, contre 59 % qui les utilisent en deuxième intention. Cette pratique témoigne d'une connaissance globalement satisfaisante des recommandations actuelles et d'une intégration progressive des AOD dans la stratégie thérapeutique de la maladie thromboembolique et de la fibrillation atriale.

L'un des principaux avantages des AOD par rapport aux antagonistes de la vitamine K (AVK) réside dans l'absence de nécessité d'une surveillance biologique régulière de l'INR, ce qui simplifie la prise en charge et améliore potentiellement le confort des patients.

Cependant, plusieurs facteurs limitent encore leur utilisation en Algérie. Le coût élevé des AOD et leur absence de remboursement constituent les principaux obstacles à leur prescription. Ces contraintes économiques sont suivies par l'absence ou l'accessibilité limitée des antidotes spécifiques ainsi que par l'absence de tests biologiques spécifiques permettant une surveillance de leur activité anticoagulante en pratique courante. Ces différents éléments peuvent contribuer à expliquer la persistance d'une utilisation importante des AVK malgré les avantages pharmacologiques et pratiques des AOD.

Conclusion

Les AOD occupent une place croissante dans la pratique médicale en Algérie, notamment en cardiologie. Malgré leurs avantages par rapport aux AVK, leur utilisation reste limitée principalement par leur coût élevé, l'absence de remboursement et l'accès insuffisant aux antidotes et aux moyens de surveillance. L'amélioration de leur accessibilité pourrait favoriser une utilisation plus large et adaptée aux recommandations.

Références

- 1-J.F SCHVED. **Physiologie de l'hémostase**. Faculté de Médecine Montpellier janvier 2015.
- 2-Annie BEZEAUD et Marie- Claude GUILLIN. **Physiologie et exploration de l'hémostase**. UFR de Médecine Paris 7 – Denis Diderot janvier 2015.
- 3-<https://www.vidal.fr/substances/3755/fluidione/> mise à jour 01 février 2019.
- 4- Sébastien FAUREa, Jacques BUXERAUDb, Les anticoagulants oraux directs ou AOD. Faculté de pharmacie, 16 boulevard Daviers, 49045 Angers, France.
- 5- Faure S. Nouveaux anticoagulants oraux. Actual Pharm. avr 2013 ;52(525) :55-58
- 6-OMÉDIT. Prévenir les erreurs liées aux médicaments Anticoagulants Oraux Directs « Never Events AOD ». 2015.
- 7- Muriel Barreau. Des médicaments anti vitamine K aux nouveaux anticoagulants oraux, état des lieux et surveillance. 20 Novembre 2015.